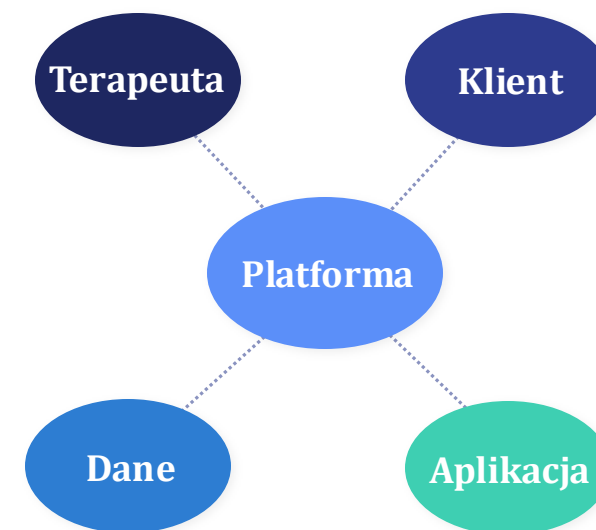


E-terapia jako praktyka i przyszłość pomocy psychologicznej

dr inż. Mateusz Pomianek

Od definicji i kwalifikacji do praktyki klinicznej, pomiaru, bezpieczeństwa i technologii przyszłości



Cały ekosystem pomocy,
a nie tylko pojedyncze połączenie

DLACZEGO TEMAT JEST WAŻNY WŁAŚNIE TERAZ?

Zbieg czterech niezależnych trendów społecznych i technologicznych

1

Rosnące zapotrzebowanie

Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego rosną szybciej niż liczba specjalistów.

2

Niedobór specjalistów

Strukturalny deficyt kadr, szczególnie poza dużymi miastami.

3

Normalizacja kontaktu zdalnego

Doświadczenie pandemii znormalizowało sesje wideo jako standard.

4

Cyfryzacja i nowe technologie

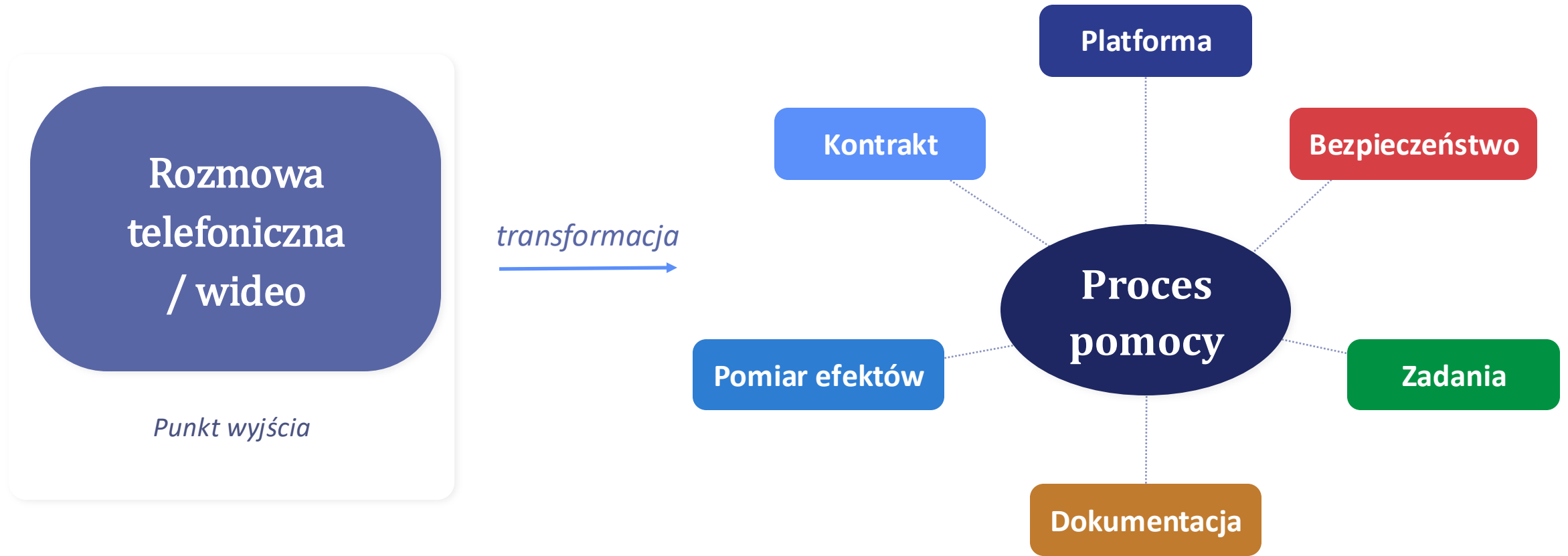
Aplikacje, urządzenia mobilne, VR i generatywna AI jako nowe narzędzia.

Presja na zmianę modelu pomocy psychologicznej

To dobry moment, żeby uczyć się tego tematu krytycznie, zanim zrobi to za nas rynek

OD TERAPII NA ODLEGŁOŚĆ, DO CYFROWEGO EKOSYSTEMU

Od zamiany kanału do projektowania całego procesu



Każdy element systemu wymaga osobnej decyzji klinicznej i organizacyjnej

CZYM JEST E-TERAPIA?

Definicja robocza na potrzeby tego wykładu

Profesjonalna pomoc psychologiczna lub psychoterapeutyczna realizowana **całkowicie albo częściowo** z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

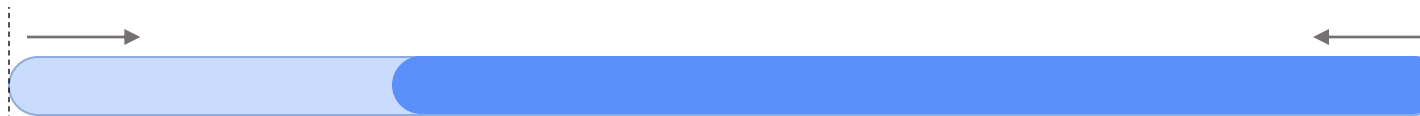
„profesjonalna”

Wyklucza samodzielne korzystanie z aplikacji bez udziału specjalisty.

„całkowicie albo częściowo”

Obejmuje zarówno czystą terapię online, jak i modele hybrydowe.

Stacjonarna

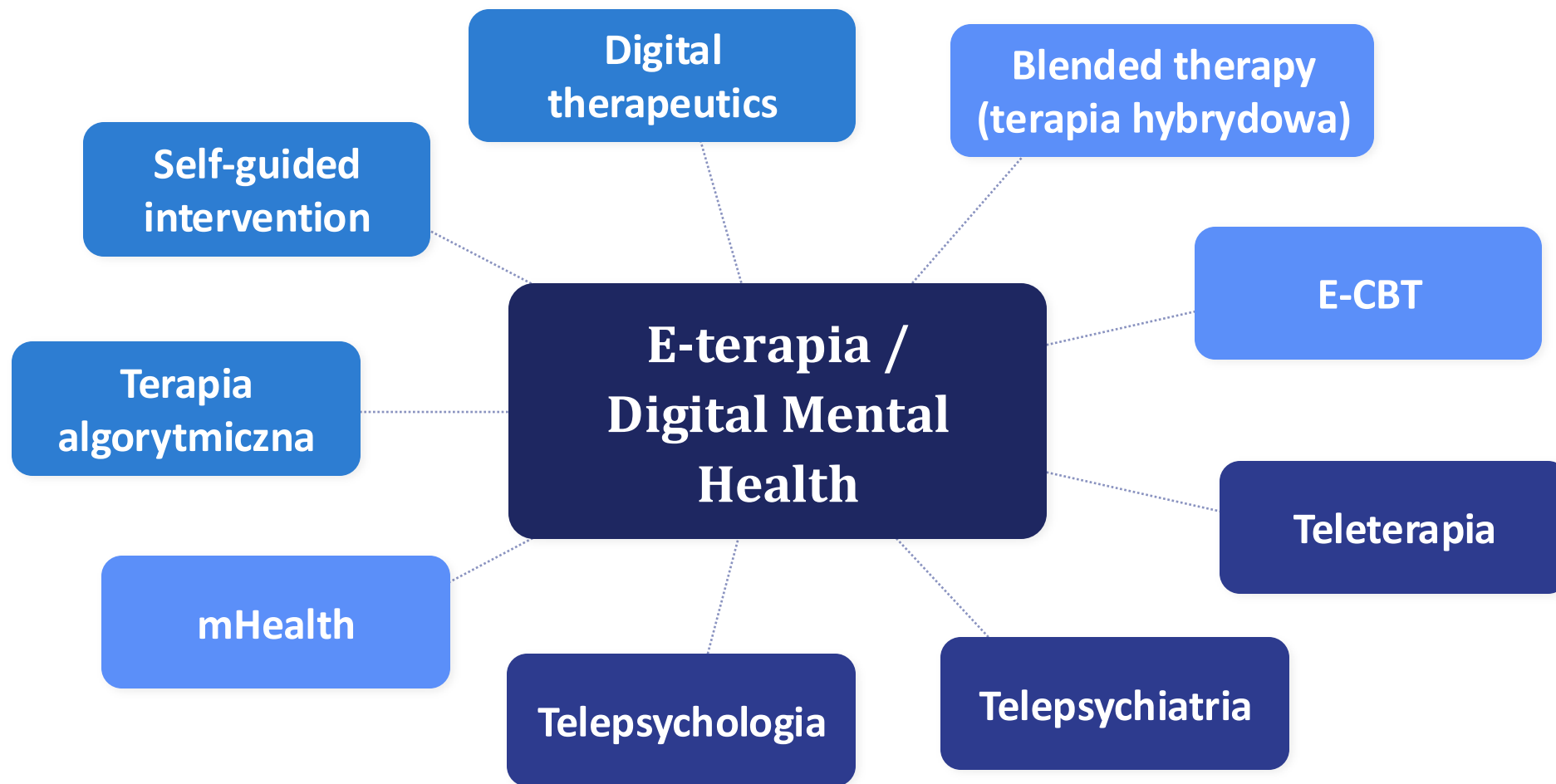


Zdalna

e-terapia obejmuje tę część spektrum

MAPA POJĘĆ

Dziewięć terminów, trzy klastry znaczeniowe



● pojęcia kliniczne

● pojęcia metodologiczne

● pojęcia technologiczne

E-TERAPIA A KLASYCZNA TERAPIA ONLINE

Sesja wideo jest jednym z elementów, nie całością procesu

Sesja wideo

+ Pomiar efektów

+ Automatyzacja zadań

+ Materiały między sesjami

+ Monitoring

**E-terapia
(całość)**

Jeśli prowadzicie tylko sesje przez kamerę, to korzystacie z najprostszej, najbardziej ograniczonej formy tego, co technologia pozwala dziś zrobić

TYPOLOGIA INTERWENCJI CYFROWYCH

Trzy krzyżujące się osie klasyfikacji

OŚ CZASU



OŚ NADZORU



OŚ FORMATU



Konkretna interwencja zwykle łączy wartości z wszystkich trzech osi jednocześnie.

KANAŁY KOMUNIKACJI

Wybór kanału to decyzja kliniczna, nie tylko techniczna preferencja

Synchroniczne



Wideo



Audio (telefon)



Czat na żywo

Asynchroniczne



E-mail



Formularze



Dzienniczki cyfrowe

Wspierające



Aplikacje mobilne



Platformy kliniczne

Monitorujące



Śledzenie objawów



Dane z urządzeń

Immersyjne



VR



AR

Który kanał jest właściwy dla tego klienta, w tym momencie?

CO TECHNOLOGIA ZMIENIA W TERAPII?

Siedem wymiarów zmiany, do których wrócimy w dalszych częściach wykładu

1 Obecność psychologiczna

Intensywność poczucia
„bycia w kontakcie”

2 Sygnały niewerbalne

Ograniczony kadr, brak
mowy ciała

3 Kontrola otoczenia

Terapeuta nie widzi
przestrzeni klienta

4 Granice kontaktu

Łatwiejszy dostęp poza
sesją

5 Tempo komunikacji

Opóźnienia, przerwy,
asynchroniczność

6 Ślad zapisu

Więcej danych zapisanych trwale

7 Odpowiedzialność organizacyjna

Platforma i instytucja jako
współodpowiedzialne

KORZYŚCI I KOSZTY CYFROWEJ MEDIACJI

Znaczenie każdego punktu zależy od konkretnego klienta i kontekstu

KORZYŚCI

- Większa dostępność geograficzna
- Elastyczność czasowa
- Niższe bariery wejścia dla części klientów
- Łatwiejsza kontynuacja terapii przy zmianie miejsca
- Możliwość częstego monitorowania

KOSZTY / RYZYKA

- Zmęczenie ekranowe (Zoom fatigue)
- Ryzyko uproszczenia relacji terapeutycznej
- Zależność od infrastruktury technicznej
- Trudniejsza ocena kontekstu i bezpieczeństwa
- Mniejsza kontrola nad jakością kontaktu

Żadna z tych korzyści i kosztów nie jest absolutna, bo wszystko zależy od klienta, problemu i kontekstu

DLA KOGO E-TERAPIA MOŻE BYĆ SZCZEGÓLNIIE UŻYTECZNA?

Sześć grup, dla których zdalność jest realną korzyścią kliniczną

1

Ograniczona mobilność

Bariery fizyczne lub wynikające ze stanu zdrowia

2

Odległość od specjalisty

Małe miejscowości, brak lokalnej oferty pomocy

3

Studenci, ruchliwy tryb życia

Częste zmiany miejsca zamieszkania

4

Lęk społeczny

Łatwiejszy pierwszy kontakt niż wizyta w gabinecie

5

Kontynuacja przy przeprowadzce

Zachowanie ciągłości procesu terapeutycznego

6

Częste monitorowanie

Krótki, regularny kontakt logistycznie niemożliwy stacjonarnie.

E-terapia nie jest uniwersalnie lepsza. Jest lepsza dla konkretnych barier i potrzeb.

KIEDY E-TERAPIA MOŻE BYĆ NIEWYSTARCZAJĄCA?

Rozpoznanie przeciwwskazania jest tak samo ważną kompetencją jak prowadzenie terapii



Ostry kryzys suicydalny

Wymaga bezpośredniej,
kontrolowanej interwencji.



Psychoza

Utrudniona ocena stanu i kontaktu
poznawczego przez ekran.



Ciężkie uzależnienie

Aktywna faza dekompensacji.



Przemoc domowa

Brak możliwości zapewnienia
bezpiecznej rozmowy.



Brak prywatności

Niemożliwość zapewnienia warunków
swobodnej wypowiedzi.



Niestabilny kontakt techniczny

Łącze, sprzęt lub dostępność uczestnika

Umiejętność rozpoznania, kiedy e-terapia nie jest właściwym wyborem, to kluczowa kompetencja kliniczna

MODEL KWALIFIKACJI KLIENTA

Siedem kryteriów przechodzonych świadomie przy każdym kliencie

- 1 Ocena problemu:** rodzaj i charakter zgłaszanej trudności
- 2 Nasilenie objawów:** łagodne, umiarkowane, ciężkie
- 3 Ocena ryzyka:** suicydalnego, przemocy, dekompensacji
- 4 Zdolność do samoregulacji** między sesjami
- 5 Kompetencje cyfrowe** i komfort z technologią
- 6 Warunki lokalowe** i stabilność łącza
- 7 Dostępność lokalnej pomocy** na wypadek eskalacji

Wynik kwalifikacji



E-terapia

Model hybrydowy

**Terapia stacjonarna /
skierowanie**

DECYZJA O MODALNOŚCI

Wybór kanału wynika z potrzeb, preferencji i poziomu ryzyka, nie z przyzwyczajenia

**Czy potrzebny jest kontakt
w czasie rzeczywistym?**

TAK - czas rzeczywisty

Wideo

Stabilne łącze,
prywatne miejsce

Hybrydowy

Sesje + kontakt
w międzyczasie

NIE - można odroczyć

Tekst

Refleksyjność,
bez tonu głosu

Asynchroniczny

Psychoedukacja,
monitorowanie

Wysokie ryzyko → terapia stacjonarna

MODELE PRACY TERAPEUTYCZNEJ ONLINE

Sześć architektur procesu, nie jeden format „terapii online”

Przeniesienie sesji

To, co stacjonarnie - teraz przez wideo, bez zmiany struktury.

Model mieszany

Sesje zdalne i stacjonarne w jednym procesie.

Model zadaniowy

Praca między sesjami, sesja jako przegląd i planowanie.

Psychoedukacyjno-terapeutyczny

Moduły wiedzy połączone z rozmową.

Monitorowanie objawów

Częsty, krótki kontakt skoncentrowany na śledzeniu stanu.

Opieka stopniowana

Intensywność interwencji rośnie wraz z potrzebą (stepped care).

Wybór modelu, podobnie jak modalności, powinien wynikać z kwalifikacji, a nie tylko z dostępnej technologii.

PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE SESJI

Lista kontrolna przed każdą sesją zdalną



Sprzęt

Komputer/tablet, kamera, mikrofon, słuchawki



Łącze internetowe

Stabilność ważniejsza niż maksymalna prędkość



Oświetlenie

Widoczność twarzy, brak światła z tyłu



Platforma

Przetestowana, zgodna z wymogami poufności



Plan awaryjny

Alternatywny kanał - telefon jako backup



Aktualizacje i test kanału

Sprawdzone przed, nie podczas sesji

Przygotowanie techniczne jest częścią profesjonalizmu, podobnie jak przygotowanie gabinetu przed wizytą stacjonarną.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA KLIENTA

Terapeuta nie kontroluje tego środowiska, ale może je uzgodnić i sprawdzić

Środowisko klienta - schemat



Brak osób trzecich w kadrze i poza nim

Pytania kontrolne na początku sesji

- Czy jest Pan/Pani sam(a) w pomieszczeniu?
- Czy może Pan/Pani mówić swobodnie, głośno?
- Czy ktoś może usłyszeć tę rozmowę z sąsiedniego pomieszczenia?
- Gdzie aktualnie Pan/Pani się znajduje?
- Co zrobi Pan/Pani, jeśli będzie trzeba przerwać połączenie?

PIERWSZA SESJA ONLINE - PROCEDURA

Sformalizowana warstwa proceduralna, której terapia stacjonarna nie wymaga

- 1 Weryfikacja tożsamości klienta
- 2 Ustalenie lokalizacji w momencie sesji
- 3 Zebranie danych kontaktowych
- 4 Wskazanie osoby alarmowej
- 5 Zebranie zgód (terapia zdalna, dane, nagrywanie)
- 6 Ustalenie oczekiwań i ograniczeń kontaktu
- 7 **Przedstawienie zasad reagowania kryzysowego**

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY ONLINE

Więcej elementów procesu musi być wyraźnie spisanych niż w terapii stacjonarnej

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY - ŚRODOWISKO CYFROWE

§1 Zakres i kanały kontaktu

Co jest objęte terapią, a co nie.

§3 Odwoływanie sesji

Zasady przełożenia i odwołania.

§5 Nagrywanie sesji

Czy, przez kogo, na jakich zasadach.

§7 Sytuacje kryzysowe

Komunikacja między sesjami i reagowanie.

§2 Czas odpowiedzi

Na wiadomości między sesjami.

§4 Płatności

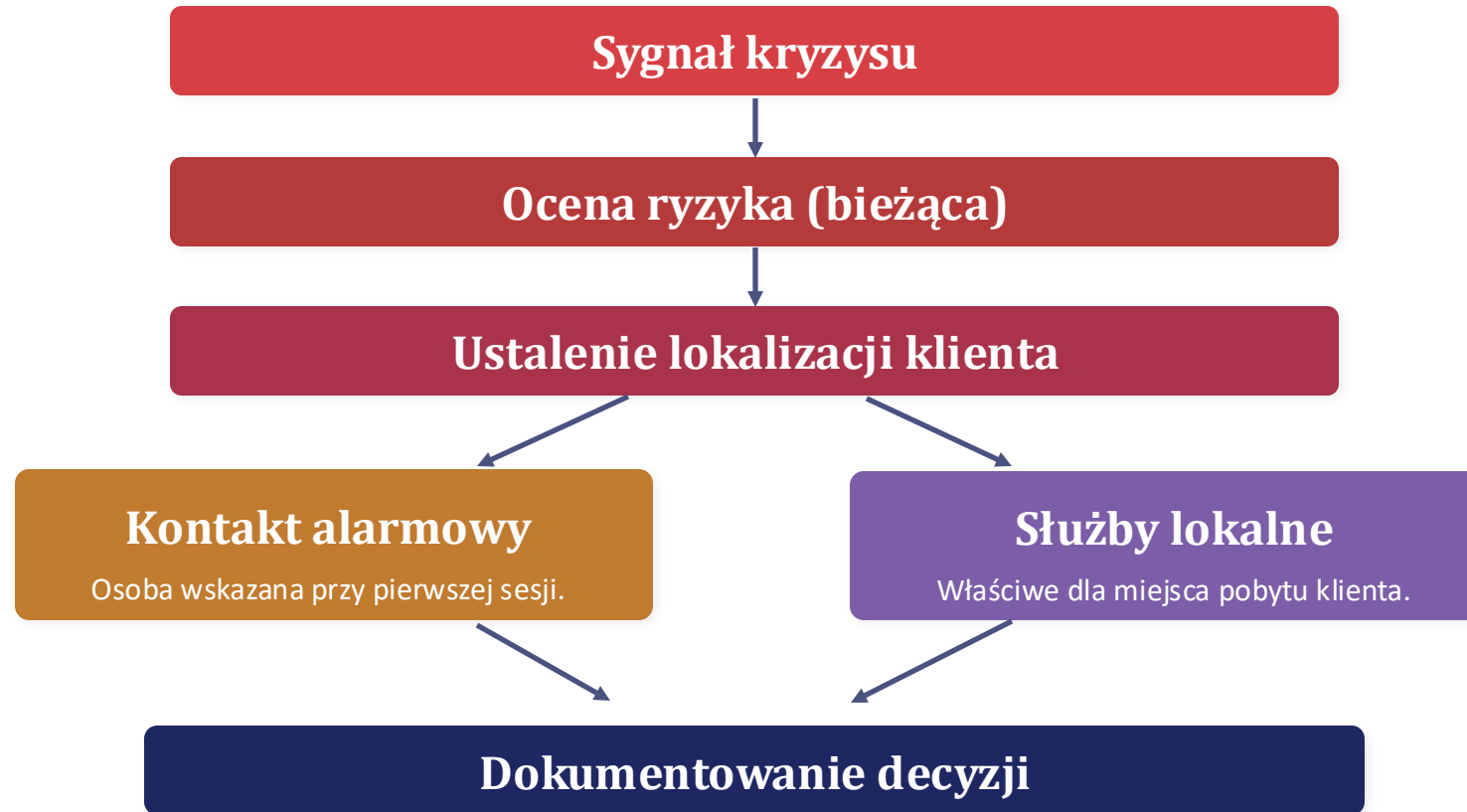
Sposób, terminy, polityka przy nieobecności.

§6 Dokumentacja i poufność

W środowisku cyfrowym.

PROTOKÓŁ SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Element spinający kwalifikację, kontrakt i przygotowanie sesji



Granice odpowiedzialności terapeuty pracującego zdalnie to ocenić ryzyko i zorganizować pomoc. Musi być on świadomy, że nie jest w stanie fizycznie zapewnić bezpieczeństwa.

RELACJA TERAPEUTYCZNA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

To, co się nie zmienia. To, co się zmienia.



Mechanizm zmiany pozostaje ten sam. Zmienia się sposób budowania i podtrzymywania relacji.

BUDOWANIE SOJUSZU TERAPEUTYCZNEGO ONLINE

Sześć technik aktywnego potwierdzania obecności

1 Sprawdzenie rozumienia

„Czy dobrze rozumiem, że...?”

2 Nazywanie przerw technicznych

„Wróćmy do tego, co Pan/Pani mówił/a”

3 Intensywna parafraza

pokazuje, że terapeuta śledzi wypowiedź

4 Częste podsumowania

zamykanie fragmentów rozmowy

5 Eksplicytne nazywanie emocji

„Widzę, że to poruszający temat”

6 Powtarzane uzgadnianie celów

nie tylko na starcie procesu

Sojusz, który stacjonarnie buduje się częściowo automatycznie, online wymaga świadomej, powtarzanej pracy.

EMPATIA CYFROWA

Kompensacja ograniczonego kanału niewerbalnego

Ograniczony kanał

- Mimika
- Ton głosu
- Mowa ciała
- Mikroekspresje

*widoczne tylko częściowo lub
zniekształcone przez kompresję*



Precyzyjny język

Wypowiedziana walidacja

Klaryfikacja

Świadome pauzy

Wolniejsze tempo

Pytania
metakomunikacyjne

Gdy obserwacja jest niepewna to pytamy wprost: „co się teraz dzieje?”, a nie zgadujemy.

KONTAKT WZROKOWY I ZACHOWANIE PRZED KAMERA

Trzy zasady techniczne o realnym znaczeniu klinicznym

Wysokość kamery

✗ poniżej linii oczu - efekt „patrzenia z góry”

✓ na wysokości oczu - naturalny kontakt

Kadrowanie

✗ przypadkowe, zbyt bliskie lub dalekie

✓ stabilne, widoczność od piersi wzwyż

Ekran vs obiektyw

✗ patrzenie na obraz klienta na ekranie

✓ patrzenie w obiektyw = kontakt wzrokowy

Mimika powinna być nieco bardziej wyrazista, a reakcje wolniejsze - kompresja i opóźnienie obrazu spłaszczają subtelne sygnały.

PRACA Z CISZĄ, OPÓŹNIENIEM I ZAKŁÓCENIAMI

Dwa rodzaje ciszy, jedna zasada postępowania

Cisza terapeutyczna

Naturalna przestrzeń do przetworzenia i refleksji - to część procesu, a nie problem.



jak rozróżnić w czasie rzeczywistym?

Cisza techniczna

Efekt zerwanego lub niestabilnego połączenia; wymaga aktywnego sprawdzenia.

„Czy mnie Pan/Pani słyszy?”
aktywne sprawdzenie zamiast czekania i zgadywania

*Krótką pauzę przed odpowiedzią ogranicza nakładanie się głosów przy opóźnieniach transmisji.
Nazwanie zakłócenia wprost zapobiega odczytaniu go jako dystansu emocjonalnego terapeuty.*

PRACA Z CIAŁEM I EMOCJAMI ONLINE

Zakres obserwacji jest węższy, a więc pewność interpretacji też

WIDOCZNE W KADRZE

Oddech:	przyspieszenie, spłycenie przy poruszającym temacie
Głos:	ton, tempo, drżenie, zmiany głośności
Mimika:	z zastrzeżeniem ograniczeń jakości obrazu

NIEWIDOCZNE

Dłonie:	napięcie, zaciskanie pięści poza kadrem?
Postawa:	nogi, ułożenie ciała poza widocznym obszarem?
Otoczenie:	kontekst pomieszczenia i osoby poza kadrem?

„Zauważyłem/-am, że głos się zmienił - co się teraz dzieje w ciele?”
gdy obserwacja jest niepewna, pytamy

WIDEOTERAPIA

Najbliższa kontaktowi stacjonarnemu - i najbardziej wymagająca technicznie

ZALETY

- Dostęp do mimiki i części mowy ciała
- Możliwość obserwacji reakcji w czasie rzeczywistym
- Najbliższy odpowiednik kontaktu twarzą w twarz

OGRANICZENIA

- Zmęczenie poznawcze ("Zoom fatigue")
- Ekspozycja domowego otoczenia klienta
- Silna zależność od jakości połączenia

Wymaga najwyższych standardów przygotowania technicznego ze wszystkich modalności.

TERAPIA TEKSTOWA

Większa refleksyjność, mniejszy dostęp do tonu

podgląd rozmowy tekstowej

Klient: „OK. Jasne. Zrobię to.”

Terapeuta: „Jak to brzmiało, kiedy Pan/Pani to pisał/a - spokojnie, czy z napięciem?”

*ten sam zestaw słów:
żart, sarkazm czy szczerzy niepokój?*

ZALETY

- Większa refleksyjność przed odpowiedzią
- Trwały zapis rozmowy dostępny do ponownego odczytania

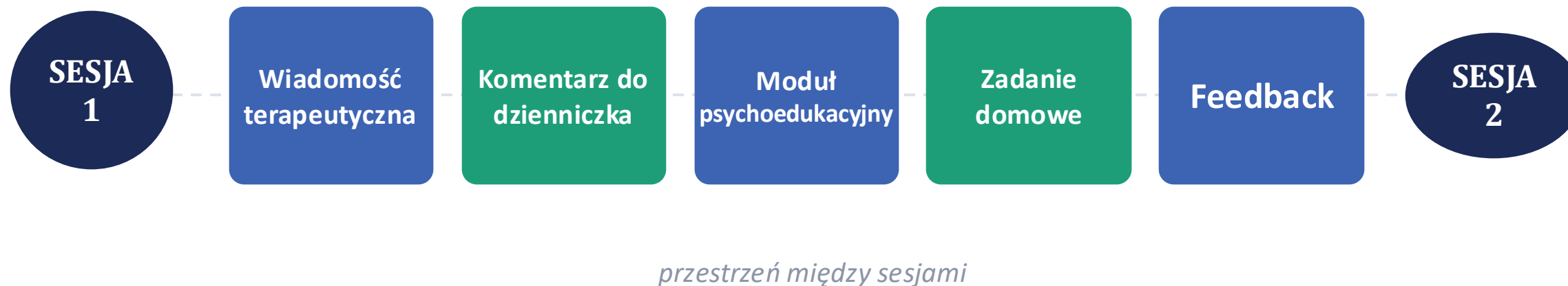
OGRANICZENIA

- Brak tonu głosu - utrata bogatego źródła emocji
- Naturalne opóźnienie reakcji
- Wyższe ryzyko błędnej interpretacji intencji

Wymaga szczególnej precyzji języka i częstszej klaryfikacji - nawet w prostych wymianach.

INTERWENCJE ASYNCHRONICZNE

Wypełnienie przestrzeni między sesjami - nie ich zastąpienie



Funkcja to podtrzymanie kontinuum procesu, ale bez rozmywania granic dostępności terapeuty

MIKROINTERWENCJA TEKSTOWA

Projektowanie odpowiedzi terapeutycznej w kanale tekstowym

ĆWICZENIE 1

Materiał

krótka wiadomość klienta przesłana między sesjami (np. o trudnym dniu i narastającym niepokoju).

Zadanie: zaprojektuj odpowiedź uwzględniającą

- | | |
|---|--|
| ☐ Walidację stanu emocjonalnego | ☐ Klaryfikację niejasnych elementów |
| ☐ Pytanie otwarte rozwijające refleksję | ☐ Ostrożnie sformułowaną hipotezę roboczą |
| ☐ Restrukturyzację poznawczą (jeśli adekwatna) | ☐ Propozycję zadania lub kroku do sesji |

Format pracy

Indywidualnie lub w parach, następnie dyskusja grupowa.

Pytanie kontrolne

Czy każde słowo w tej krótkiej wiadomości pracuje na rzecz relacji i procesu?

E-CBT JAKO NAJLEPIEJ ZBADANY OBSZAR

Cyfrowa terapia poznawczo-behawioralna



E-CBT to najlepiej zbadany obszar cyfrowej pomocy psychologicznej

TERAPIA HYBRYDOWA (BLENDED THERAPY)

Oś główna procesu wsparta narzędziami cyfrowymi



praca między sesjami - wypełniona, nie pusta

Materiały dostępne na żądanie · automatyczne przypomnienia · pomiar zintegrowany z procesem

Model łączący siłę kontaktu bezpośredniego z konsystencją wsparcia cyfrowego

TERAPIA GRUPOWA ONLINE

Sześć wyzwań specyficznych dla pracy z grupą zdalną

Uczestnik 1

Uczestnik 2

?cisza czy wyciszony?

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

?kto jest poza kadrem?

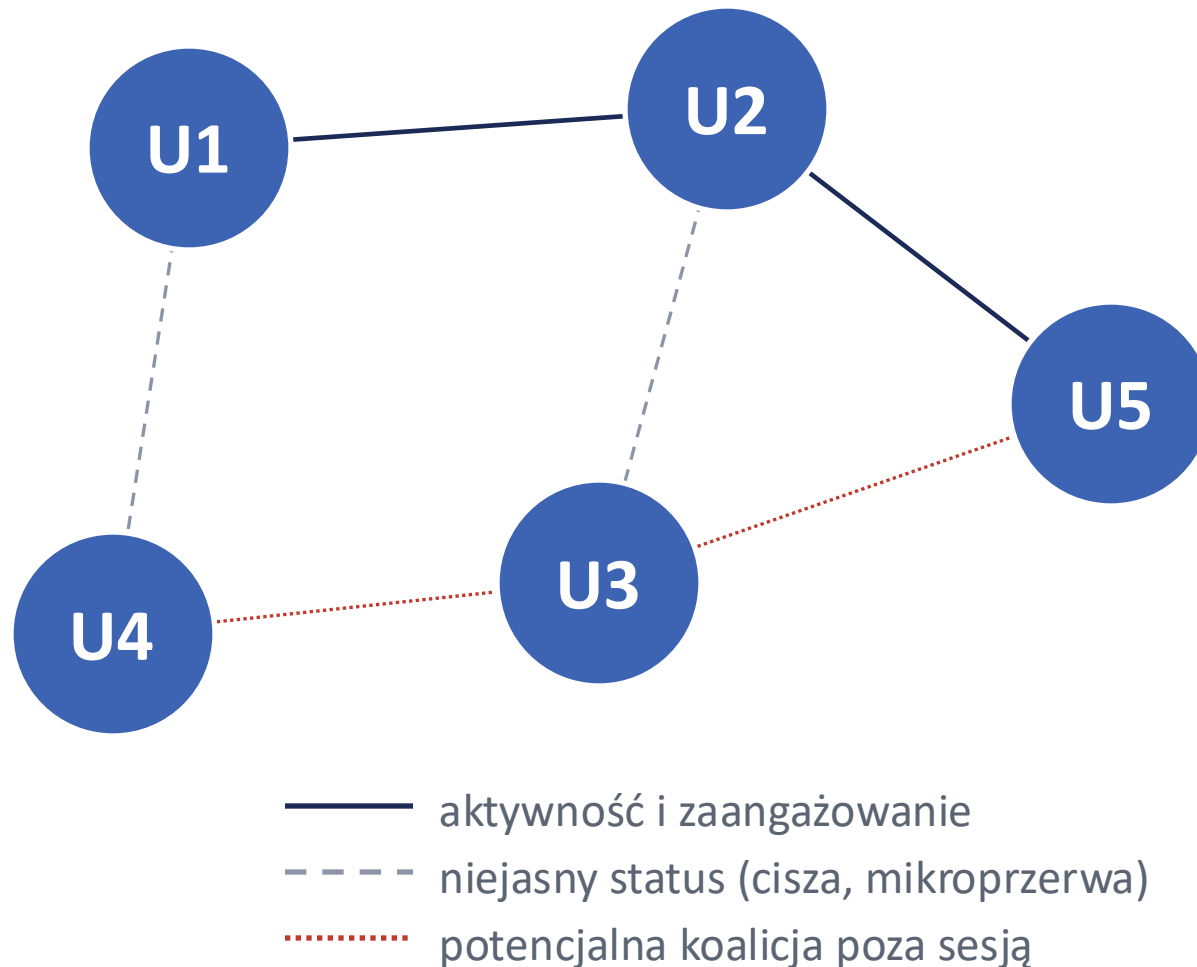
Uczestnik 6

- **Kolejność wypowiedzi** - trudniejsza do naturalnego zarządzania niż w pokoju
- **Moderacja** - wymaga większej aktywności i struktury
- **Cisza w grupie** - niejednoznaczna - trudniej odczytać źródło
- **Bezpieczeństwo** - osoby trzecie poza kadrem każdego uczestnika
- **Zaangażowanie** - mniej sygnałów niewerbalnych do odczytania
- **Jawne reguły** - zastępują to, co stacjonarnie „samo się dzieje”

Grupa stacjonarna ma naturalną dynamikę przestrzenną, z kolei online wymaga jawnych reguł w jej zastępstwie

DYNAMIKA GRUPY ONLINE

Te same zjawiska, węższy zestaw sygnałów



Breakout rooms (osobne pokoje)

Praca w podgrupach: funkcja bez prostego stacjonarnego odpowiednika. Daje nowe możliwości, ale wymaga przemyślanej struktury powrotu do grupy głównej.

ZASADY BEZPIECZNEJ GRUPY CYFROWEJ

Sześć elementów kompletnego systemu bezpieczeństwa

☐ **Regulamin grupy**

spisany, znany wszystkim
przed pierwszą sesją

☐ **Zakaz nagrywania**

jasno komunikowany i
uzasadniony uczestnikom

☐ **Słuchawki jako standard**

nie jako opcja, bo to chroni
prywatności wszystkich

☐ **Kamera włączona**

zasada lub wyjątek,
uzgodniona z grupą

☐ **Prywatne miejsce**

warunek wstępny
uczestnictwa każdej osoby

☐ **Kontrakt poufności**

procedura zgłaszania i plan
awaryjny

Bezpieczeństwo grupy cyfrowej wymaga więcej sformalizowanych reguł niż grupa stacjonarna

APLIKACJE MOBILNE W ZDROWIU PSYCHICZNYM

Sześć funkcji najczęściej wykorzystywanych w praktyce

Codzienne, krótkie wpisy dają bogatszy obraz przebiegu objawów w czasie niż retrospektywny opis na sesji.

Dzienniczki

nastroju, snu, lęku

Przypomnienia

o zadaniach, lekach

Oddech i mindfulness

ćwiczenia prowadzone

Ekspozycja wspomagana

hierarchie, monitoring

Monitoring zachowań

aktywność, używki

Skale objawowe

wypełniane cyklicznie

Dane behawioralne z monitoringu uzupełniają samoopis klienta - prowadzą do tematu pomiaru efektów.

Element nadzorowanej e-terapii albo czysto samopomocowego użycia - wymaga krytycznej oceny (patrz: dalej w tej części)

PLATFORMY INTERNETOWE DO TERAPII

Sześć kryteriów wyboru infrastruktury, nie tylko wygody interfejsu

1 Bezpieczeństwo

szyfrowanie, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

2 Stabilność

jakość połączenia, dostępność serwerów

3 Zgodność prawna

RODO i lokalne regulacje dot. danych medycznych

4 Zarządzanie zgodami

wbudowane w system, nie poza nim

5 Dokumentacja

notatki zgodne z wymogami zawodowymi

6 Konta i eksport danych

przenośność i kontrola klienta nad danymi

Wybór platformy to decyzja o infrastrukturze procesu klinicznego - nie kwestia wygody interfejsu.

PROBLEM JAKOŚCI APLIKACJI MENTAL HEALTH

Popularność i estetyka to nie dowód skuteczności klinicznej

CO WIDAĆ

- Wysokie oceny w sklepie aplikacji
- Atrakcyjny, dopracowany interfejs
- Deklaracje skuteczności w opisie
- Entuzjastyczne cytaty użytkowników

CZEGO NIE WIDAĆ

- Solidnej walidacji klinicznej
- Opublikowanej metodologii badań
- Informacji o ryzyku szkody
- Procedur na wypadek kryzysu

Ryzyko: fałszywe poczucie pomocy przy braku realnego wsparcia - szczególnie w sytuacji kryzysu.

JAK OCENIAĆ NARZĘDZIE CYFROWE?

Siedem kryteriów do systematycznego stosowania

1

Cel kliniczny

jasno zdefiniowany
problem

2

Grupa docelowa

dla kogo projektowano
i na kim testowano

3

Dowody empiryczne

jakość i liczba badań

4

Autorzy instytucja

kompetencje, konflikt
interesu

5

Ryzyko szkody

możliwe negatywne
skutki użycia

6

Prywatność danych

co, jak i komu jest
przekazywane

7

Procedury kryzysowe

i możliwość usunięcia
danych

AUDYT FIKCYJNEJ APLIKACJI

Zastosowanie macierzy oceny do konkretnego przykładu

ĆWICZENIE 2

Materiał

*opis fikcyjnej aplikacji do „redukcji stresu i lęku”
wraz z materiałem marketingowym.*

Zadanie: oceń narzędzie, analizując

- | | |
|---|--|
| ☐ Deklarowany cel vs to, co aplikacja robi | ☐ Czy przywołane dowody są weryfikowalne |
| ☐ Czy mechanizm działania ma sens psychologiczny | ☐ Co wynika z polityki prywatności |
| ☐ Ryzyko dla różnych grup użytkowników | ☐ Przydatność w praktyce klinicznej - werdykt |

Format pracy

Małe grupy, z prezentacją wniosków na zakończenie.

Po co to ćwiczenie?

Różne osoby, stosując tę samą macierz, czasem dochodzą do różnych, równie uzasadnionych wniosków.

POMIAR EFEKTÓW W E-TERAPII

Trajektoria zmiany, nie tylko dwa punkty w czasie

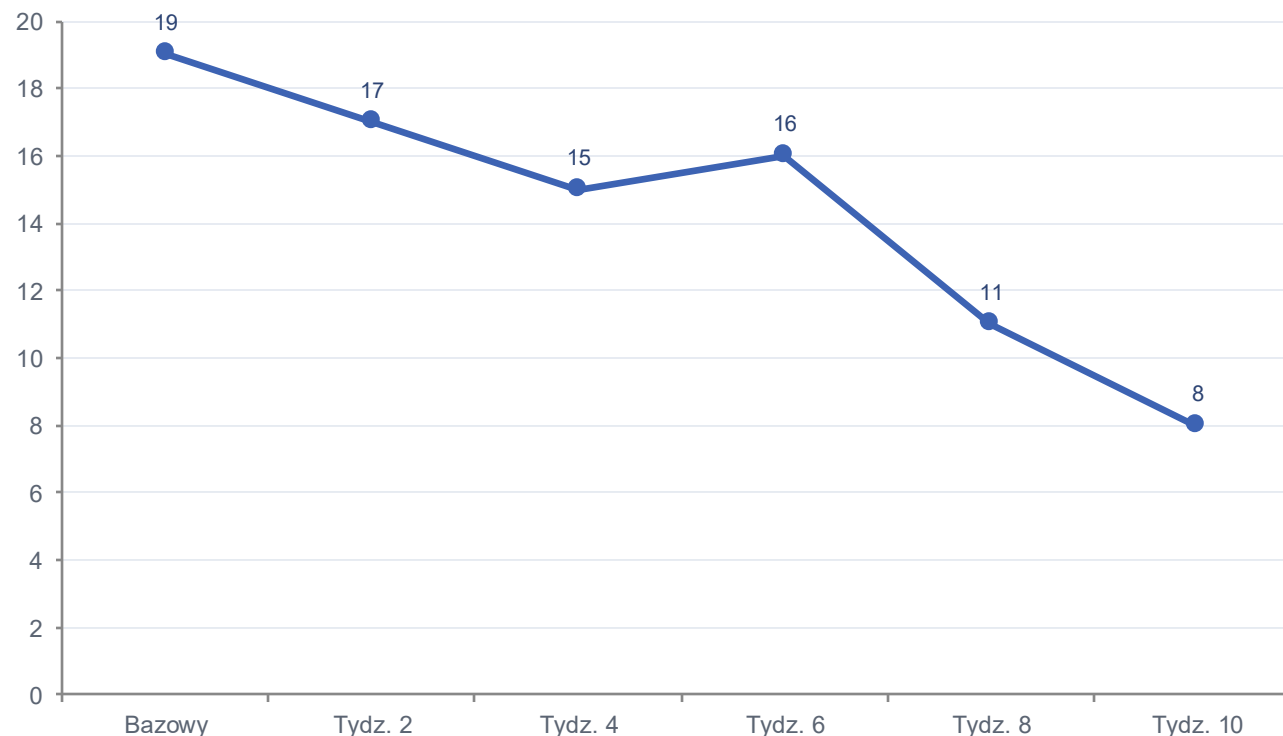
SEKCJA V

Uproszczony model



tylko start i koniec - bez obrazu trajektorii

Częste pomiary w toku terapii



Wzrost w tyg. 6 → sygnał do modyfikacji planu pomocy

SKALE I DZIENNICZKI CYFROWE

Od narzędzi specyficznych do ogólnych

PHQ-9

nasilenie symptomów
depresyjnych

GAD-7

nasilenie symptomów lęku
uogólnionego

WHO-5

ogólne samopoczucie
psychiczne

DASS-21

depresja, lęk i stres w
jednym narzędziu

CORE-OM

ogólny pomiar efektów
psychoterapii

Dzienniczki

dane jakościowe
uzupełniające skale

Każde narzędzie ma ograniczenia interpretacyjne, ale żadne nie zastępuje całościowej oceny klinicznej

ADHERENCJA I ZAANGAŻOWANIE

Co warto śledzić w przebiegu procesu cyfrowego

-  **Regularność korzystania** z aplikacji lub materiałów między sesjami - widoczna w logach systemowych
-  **Ukończenie modułów** programu psychoedukacyjnego lub terapeutycznego
-  **Wykonywanie zadań** zleconych przez terapeutę - odróżnia brak działania od nieskuteczności techniki
-  **Jakość kontaktu** zaangażowanie podczas samej sesji, niezależne od adherencji do zadań
-  **Rezygnacja (dropout)** wskaźnik często ukryty - klient może po prostu zniknąć z procesu

Niska adherencja jest wskaźnikiem implementacji procesu, a nie etykietą charakterologiczną klienta

CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI E-TERAPII?

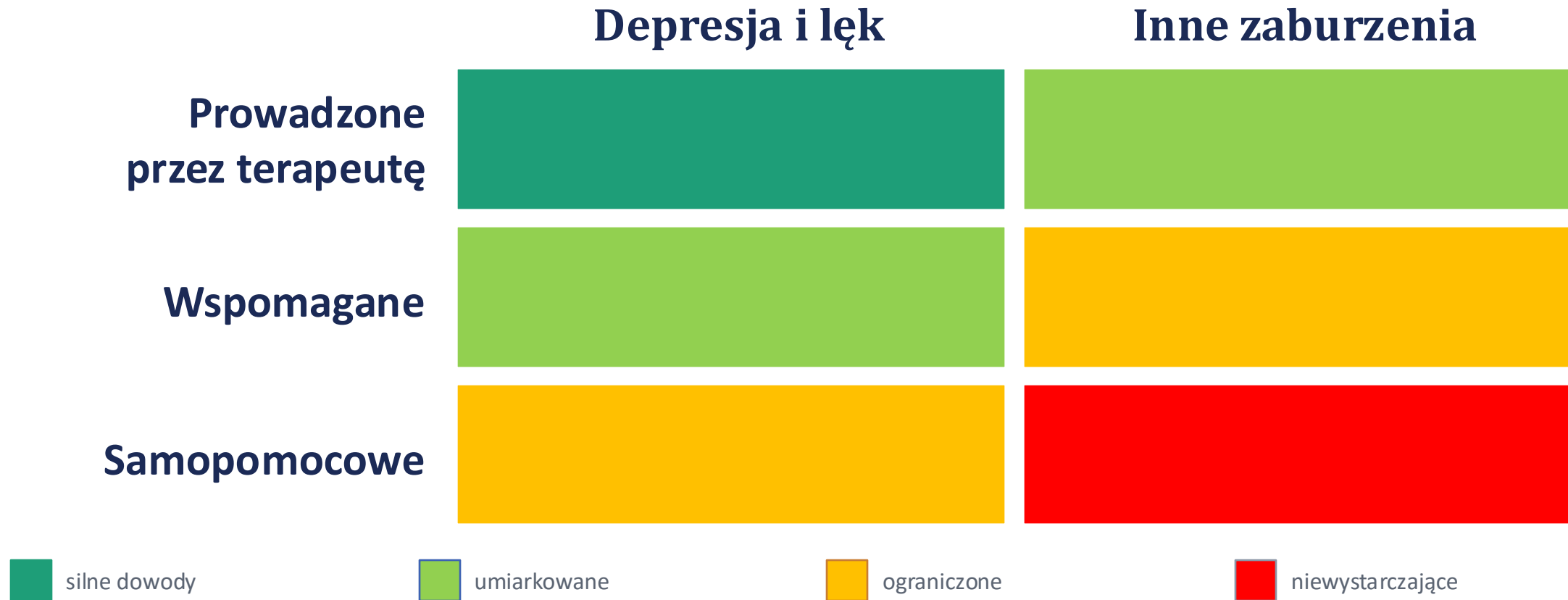
Sześć współdziałających czynników



Lista kontrolna do projektowania każdego procesu e-terapii

SKUTECZNOŚĆ E-TERAPII - INTERPRETACJA DOWODÓW

Siła dowodów zależy od kontekstu, nie jest jednolita



Właściwa postawa to ostrożny optymizm, a nie entuzjazm i nie odrzucenie

DOKUMENTACJA E-TERAPII

Więcej elementów niż w terapii stacjonarnej

Kanał i czas kontaktu

każda forma komunikacji z dokładnym zapisem

Zgody klienta

zebrane, datowane, dostępne do wglądu

Problemy techniczne

odnotowane, gdy wpływają na przebieg sesji

Zastosowane interwencje

konkretne techniki, nie tylko ogólny temat sesji

Zadania, skale, pomiary

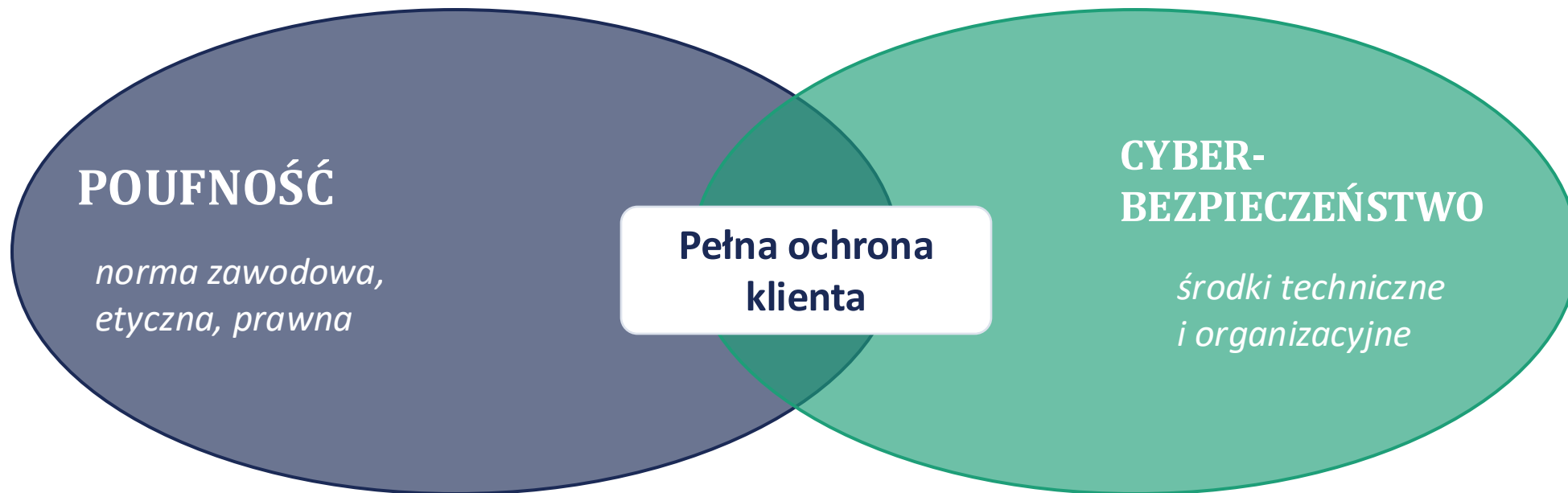
zintegrowane z dokumentacją procesu

Ryzyka, decyzje kliniczne, działania awaryjne

wymaga szczególnie szczegółowej dokumentacji - materiał do supervizji i sytuacji spornych

POUFNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

Dwa różne pojęcia, dwie różne kompetencje



Przykład rozłączenia 1

Dyskretny terapeuta na niezabezpieczonej platformie - dane mogą wyciekać niezależnie od dobrych intencji

Przykład rozłączenia 2

Bezpieczna platforma, nieostrożna praktyka terapeuty - naruszenie poufności mimo dobrej technologii

MINIMALNY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

Punkt wyjścia, poniżej którego ryzyko jest nieproporcjonalne



Szyfrowanie

komunikacji
i przechowywanych
danych



Kontrola dostępu

kto i na jakich
zasadach ma wgląd



Silne hasła i MFA

uwierzytelnianie
wieloczynnikowe



Aktualizacje

regularne łatanie
znanych podatności



Testowane kopie zapasowe

nie tylko teoretycznie
istniejące



Polityka retencji danych

jak długo i dlaczego
przechowujemy



Rozdzielone kanały

prywatne osobno
od zawodowych

PRYWATNOŚĆ KLIENTA W PRAKTYCE

Konkretne działania niezależne od jakości platformy

- **Słuchawki klienta**

ochrona przed
odsłuchaniem przez osoby
trzecie

- **Brak osób trzecich**

w pomieszczeniu podczas
sesji

- **Świadoma zgoda**

klient rozumie, na co się
zgadza, a nie tylko podpisuje

- **Informowanie
o ograniczeniach**

czego dana platforma
nie gwarantuje

- **Kontrola nagrywania**

kto, kiedy i na jakich
zasadach może nagrywać

- **Dostęp do
urządzenia**

kto jeszcze może mieć wgląd
w aplikację lub konto

Praktyki niezależne od jakości platformy, czy zabezpieczeń systemowych - odpowiedzialność terapeuty

CYKL ŻYCIA DANYCH TERAPEUTYCZNYCH

Od pozyskania do trwałego usunięcia - siedem etapów



Cykl bez nazwanej odpowiedzialności na każdym etapie jest cyklem bez realnej ochrony klienta.

BARIERY PO STRONIE KLIENTA

Sześć ograniczeń praktycznych, nie tylko brak woli

- **Wykluczenie cyfrowe**

brak dostępu do sprzętu lub stabilnego internetu

- **Brak prywatnego miejsca**

fizycznie nie ma gdzie prowadzić rozmowy

- **Niskie kompetencje techniczne**

trudność w obsłudze nowej platformy

- **Przeciążenie ekranami**

terapia jako kolejne źródło tego samego zmęczenia

- **Nieufność wobec platform**

obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych

- **Trudności z samodyscypliną**

mniej struktura, niż wizyta stacjonarna

Bariery praktyczne to nie zagrożenia bezpieczeństwa. Dotyczą realnego dostępu, nie tylko motywacji.

BARIERY PO STRONIE TERAPEUTY

Symetryczny zestaw wyzwań, rzadziej dyskutowany

- **Brak szkolenia**

w zakresie specyfiki
pracy zdalnej

- **Trudność oceny
ryzyka**

przy ograniczonym dostępie
do kontekstu klienta

- **Niepewność prawna**

niejasne lub
zmieniające się regulacje

- **Zmęczenie
pracą zdalną**

kumulacja sesji wideo bez
naturalnych przerw

- **Rozmycie granic
kontaktu**

łatwiejszy, mniej
kontrolowany dostęp klienta

- **Nadmierne poleganie
na narzędziach**

technologia zamiast
oceny klinicznej

Dwie strony tego samego zjawiska - bariery klienta i terapeuty wzajemnie się wzmacniają.

BARIERY ORGANIZACYJNE

Poziom systemowy, wykraczający poza klienta i terapeutę

- **Brak standardów**

niejednolite praktyki między terapeutami i instytucjami

- **Brak procedur awaryjnych**

na poziomie systemowym, nie tylko indywidualnym

- **Niedostateczna supervizja**

specyfiki pracy zdalnej

- **Brak bezpiecznej infrastruktury**

instytucje korzystające z niewłaściwych narzędzi

- **Odpowiedzialność za system niejasna**

kto odpowiada, gdy platforma zawodzi

- **Brak standardu dokumentacji**

dla pracy cyfrowej

Te bariery są adresowalne przez świadome projektowanie usługi

E-TERAPIA W INSTYTUCJI AKADEMICKIEJ

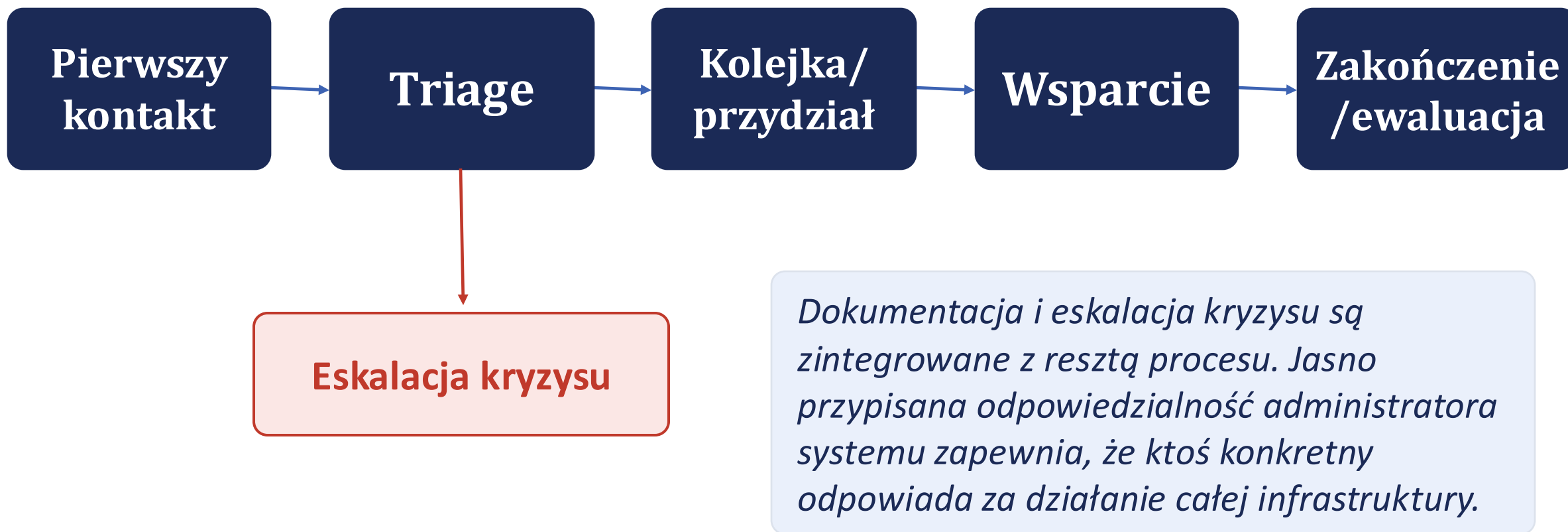
Sześć ścieżek wsparcia w środowisku uczelnianym



Niższy próg wejścia + skalowalność psychoedukacji - charakterystyka e-terapii do środowiska akademickiego

PROJEKTOWANIE USŁUGI E-TERAPII W INSTYTUCJI

Ścieżka użytkownika od pierwszego kontaktu do ewaluacji



SUPERWIZJA W E-TERAPII

Sześć funkcji wymagających adaptacji do pracy zdalnej

- **Analiza przypadków online**

specyfika materiału
z sesji zdalnych

- **Granice odpowiedzialności**

wyjaśniane i testowane
w superwizji

- **Praca z kryzysem**

przegląd decyzji podjętych
w sytuacjach kryzysowych

- **Ocena narzędzi cyfrowych**

używanych przez terapeutę
w praktyce

- **Konsultacje techniczne**

uzupełnienie konsultacji
klinicznych

- **Przeciwdziałanie izolacji zawodowej**

terapeuty pracującego
głównie zdalnie

Superwizja chroni i klienta, i terapeutę, dlatego wymaga tej samej adaptacji co sama terapia

KOMPETENCJE TERAPEUTY CYFROWEGO

Siedem wymiarów profilu kompetencyjnego

1

Kliniczne

fundamentalne,
niezależnie od kanału

2

Komunikacyjne

specyficzne dla
środowiska cyfrowego

3

Prawne

znajomość regulacji
dot. pracy zdalnej

4

Technologiczne

obsługa narzędzi,
podstawowe problemy

5

Pomiarowe

skale i dane w czasie
rzeczywistym

6

Kryzysowe

specyficzne dla pracy
na odległość

7

Krytyczna ocena systemów

stała postawa zawodowa,
a nie raz zdobyta wiedza

VR I ŚRODOWISKA IMMERSYJNE

Kontrolowane środowisko dla ekspozycji, relaksacji i treningu

- **Ekspozycja**

kontrolowane środowisko
dla lęków i fobii

- **Relaksacja**

immersyjne środowiska
wspierające regulację stanu

- **Hierarchie
ekspozycyjne**

trudne do zrealizowania
w realnym świecie

- **Ból i rehabilitacja**

pole graniczące z
psychologią zdrowia

- **Trening umiejętności
społecznych**

bezpieczne, kontrolowane
środowisko

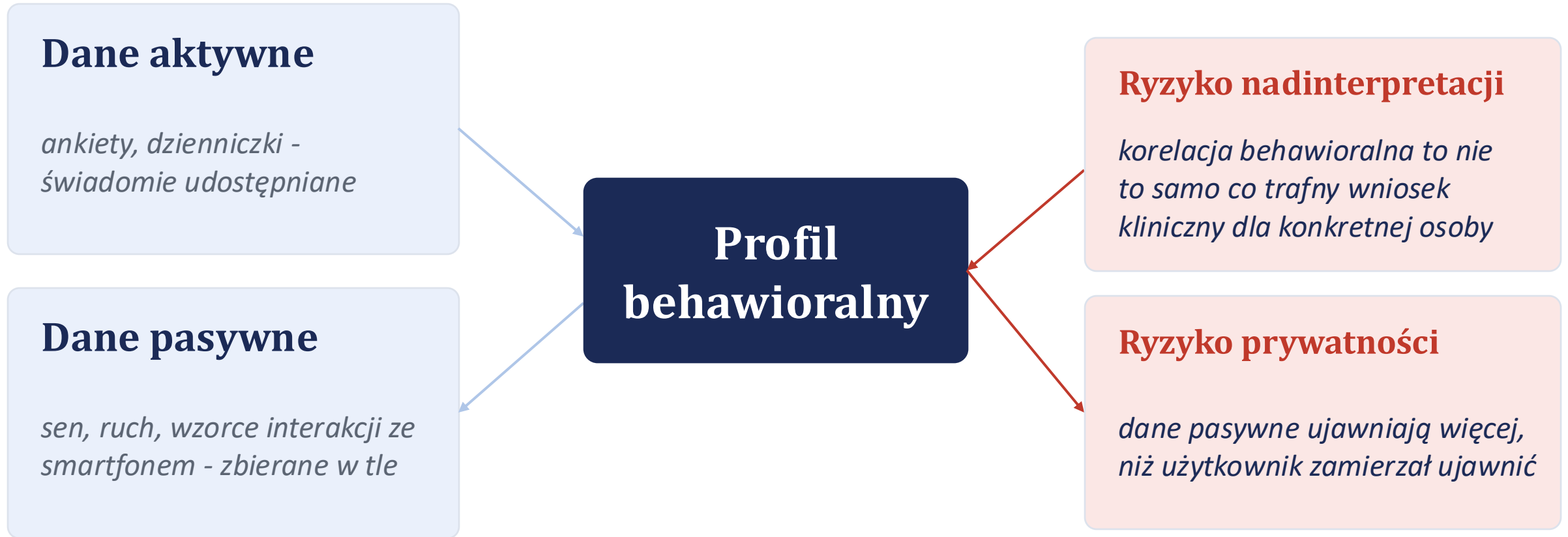
- **Kontrola bodźców**

i bezpieczeństwo uczestnika
- kluczowe wszędzie

Możliwość natychmiastowego przerywania sesji jest tak samo ważna, jak sama kontrola intensywności bodźca

CYFROWE FENOTYPOWANIE I MONITORING PASYWNY

Potencjał predykcyjny i podwójne ryzyko



AI W E-TERAPII: ZASTOSOWANIA

Siedem obszarów wsparcia

1

Triage

wstępna ocena
priorytetu zgłoszenia

2

Psychoedukacja

generowanie materiałów
i personalizacja

3

Przypomnienia

dostrojone do wzorców
aktywności klienta

4

Analiza nastroju

wspomagająca, nie
diagnostyczna

5

Personalizacja materiałów

dostrojonych do
konkretnej osoby

6

Wspomaganie dokumentacji

transkrypcja,
podsumowania

7

Symulacja rozmów

trening umiejętności w
bezpiecznym środowisku

Każde z tych zastosowań wspomaga pracę kliniczną, ale żadne jej nie zastępuje

AI W E-TERAPII: RYZYKA

Konieczna przeciwwaga do poprzedniego slajdu

1

Halucynacje

fałszywe, przekonująco
brzmiące informacje

2

Fałszywa empatia

językowa imitacja rozumienia
bez realnego rozumienia

3

Bias

odtworzenie nierówności
obecnych w danych
treningowych

4

Brak klinicznej odpowiedzialności

system nie odpowiada za
skutki odpowiedzi

5

Ujawnienie danych

przy przesyłaniu treści sesji
do systemów AI

6

Nadmierne zaufanie

użytkownika do narzędzia

7

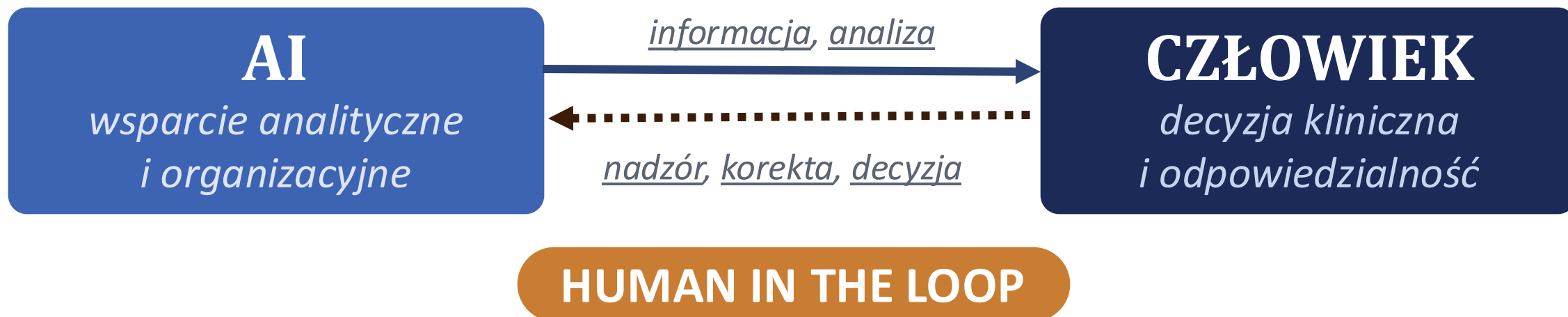
Brak walidacji

dla populacji, kontekstu
kulturowego, zaburzenia

Każde zastosowanie niesie odpowiadające mu ryzyko - odpowiedzialna praktyka wymaga znajomości obu stron

CZŁOWIEK W PĘTLI DECYZYJNEJ

Zasada nadrzędna porządkująca relację AI–klinicysta



AI może wspierać

ocenę wstępną · organizację pracy ·
generowanie materiałów

AI nie powinna przejmować

decyzji klinicznych · interpretacji
kontekstu klienta · reakcji kryzysowej

PROJEKT KOŃCOWY: WŁASNY MODEL E-TERAPII

Synteza całego materiału wykładu

PROJEKT GRUPOWY

Zadanie

zaprojektuj usługę e-terapii dla wybranej, (konkretnie) grupy odbiorców.

Elementy projektu

- ☐ Modalność i kanały komunikacji
- ☐ Narzędzia cyfrowe w procesie
- ☐ Kontrakt terapeutyczny
- ☐ Model kwalifikacji klientów
- ☐ Procedury bezpieczeństwa i protokół kryzysowy
- ☐ System pomiaru efektów
- ☐ Zasady wykorzystania AI w procesie

Format pracy

Praca grupowa z prezentacją

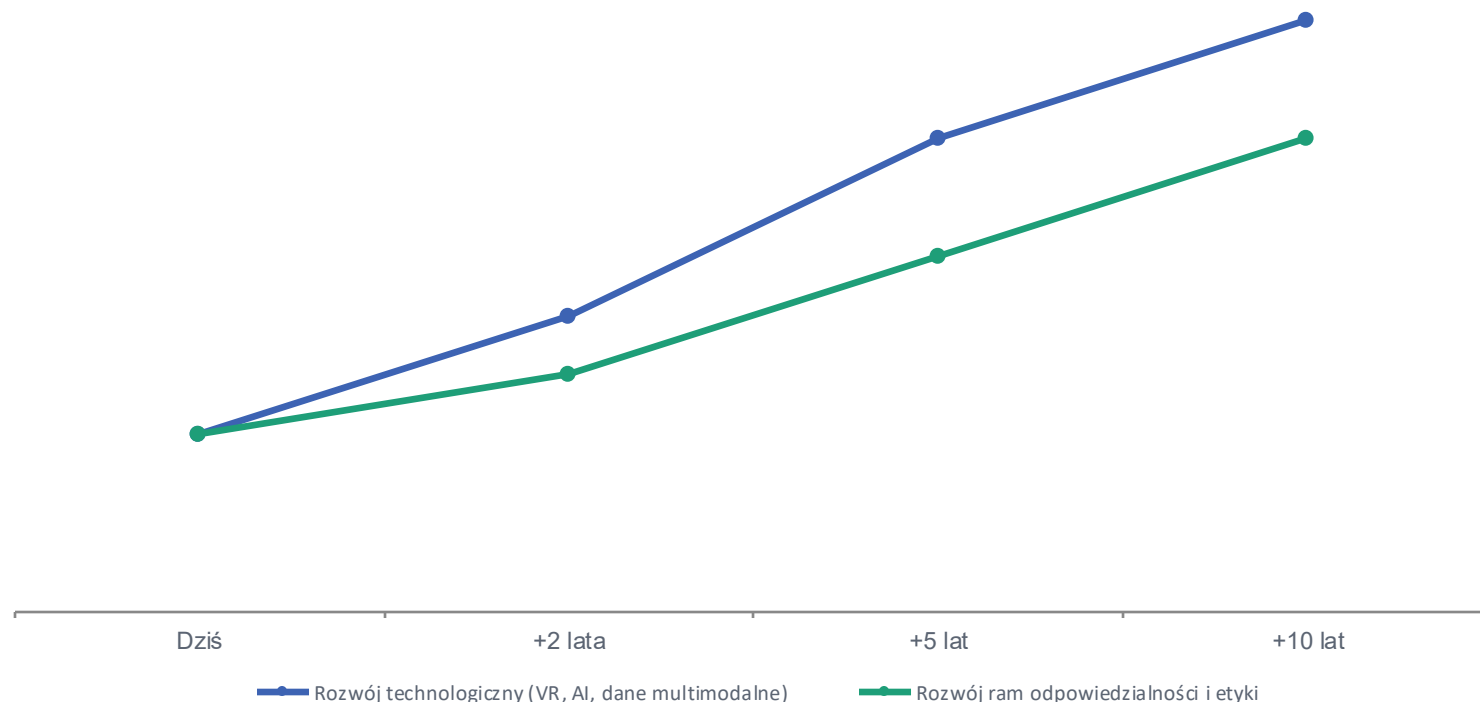
Przykładowe grupy odbiorców

Studenci I roku w adaptacji · osoby z łagodnym lękiem · pracownicy działu w zmianie organizacyjnej

Grupa musi być konkretna - by realnie wpływać na każdą decyzję projektową.

PRZYSZŁOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Dwa kierunki rozwoju, które muszą postępować razem



Coraz bardziej dostępne

Modele hybrydowe, terapia adaptacyjna, VR i AI jako standard, nie niszowy dodatek.

Ryzyko rozjazdu

Technologia bez równoległej audytowalności i ochrony autonomii pacjenta to realne zagrożenie.

Rozwój technologiczny i rozwój ram odpowiedzialności muszą postępować razem - nie jeden wyprzedzając drugi

Technologia nie zastępuje odpowiedzialności

- 1 **Dostępność** - e-terapia realnie zwiększa dostęp do pomocy psychologicznej
- 2 **Klinicznie uzasadniona** - wynikająca z kwalifikacji, nie z dostępności technologii
- 3 **Bezpieczna** - techniczne i kliniczne standardy ochrony klienta
- 4 **Etyczna** - poufność, zgoda, jasne granice odpowiedzialności
- 5 **Mierzalna** - systematyczny pomiar efektów, nie założenie skuteczności
- 6 **Udokumentowana** - pełny ślad decyzji klinicznych i przebiegu procesu

7. **Kompetentny specjalista** - fundament wszystkich poprzednich warunków

„Technologia nie zastępuje odpowiedzialności - może ją tylko wspierać.”

Pytania

Czy zwiększenie dostępności pomocy dzięki e-terapii usprawiedliwia akceptację niższego poziomu kontroli nad bezpieczeństwem klienta?

- A. Tak, ponieważ dostępność jest nadrzędnym celem każdej interwencji psychologicznej.
- B. Tak, pod warunkiem że klient zaakceptuje ryzyko w formularzu zgody.
- C. Nie automatycznie; korzyści należy zestawić z poziomem ryzyka i zabezpieczeniami.
- D. Nie, ponieważ e-terapia zawsze zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa niż terapia stacjonarna.

Czy zwiększenie dostępności pomocy dzięki e-terapii usprawiedliwia akceptację niższego poziomu kontroli nad bezpieczeństwem klienta?

- A. Tak, ponieważ dostępność jest nadrzędnym celem każdej interwencji psychologicznej.
- B. Tak, pod warunkiem że klient zaakceptuje ryzyko w formularzu zgody.
- C. Nie automatycznie; korzyści należy zestawić z poziomem ryzyka i zabezpieczeniami.
- D. Nie, ponieważ e-terapia zawsze zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa niż terapia stacjonarna.

Kiedy narzędzie cyfrowe przestaje jedynie wspierać terapię, a zaczyna współdecydować o jej przebiegu?

- A. Gdy jest wykorzystywane częściej niż raz w tygodniu
- B. Gdy jego wyniki wpływają na dobór interwencji, intensywność kontaktu lub decyzję o eskalacji pomocy
- C. Gdy aplikacja automatycznie zapisuje dane klienta
- D. Gdy klient korzysta z niej poza sesjami

Czy zwiększenie dostępności pomocy dzięki e-terapii usprawiedliwia akceptację niższego poziomu kontroli nad bezpieczeństwem klienta?

- A. Tak, ponieważ dostępność jest nadrzędnym celem każdej interwencji psychologicznej.
- B. Tak, pod warunkiem że klient zaakceptuje ryzyko w formularzu zgody.
- C. Nie automatycznie; korzyści należy zestawić z poziomem ryzyka i zabezpieczeniami.
- D. Nie, ponieważ e-terapia zawsze zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa niż terapia stacjonarna.

Kto odpowiada za błąd systemu cyfrowego?

- A. Terapeuta prowadzący proces
- B. Instytucja organizująca usługę
- C. Strony zależnie od źródła błędu
- D. Producent użytej platformy

Czy zwiększenie dostępności pomocy dzięki e-terapii usprawiedliwia akceptację niższego poziomu kontroli nad bezpieczeństwem klienta?

- A. Tak, ponieważ dostępność jest nadrzędnym celem każdej interwencji psychologicznej.
- B. Tak, pod warunkiem że klient zaakceptuje ryzyko w formularzu zgody.
- C. Nie automatycznie; korzyści należy zestawić z poziomem ryzyka i zabezpieczeniami.
- D. Nie, ponieważ e-terapia zawsze zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa niż terapia stacjonarna.

Pytania

Kto odpowiada za błąd systemu cyfrowego?

- A. Terapeuta prowadzący proces
- B. Instytucja organizująca usługę
- C. Strony zależnie od źródła błędu
- D. Producent użytej platformy

Kiedy e-terapia może być uznana za równoważną stacjonarnej?

- A. Gdy stosuje tę samą metodę
- B. Gdy trwa tyle samo czasu
- C. Gdy wyniki są porównywalne w danej populacji
- D. Gdy klient preferuje kontakt online

Dlaczego formalna zgoda może nie wystarczyć przy cyfrowym fenotypowaniu?

- A. Nie obejmuje danych pasywnych
- B. Nie dotyczy danych algorytmicznych
- C. Nie gwarantuje zrozumienia przyszłych użyć
- D. Nie pozwala na łączenie źródeł

Kiedy narzędzie cyfrowe zaczyna współdecydować o terapii?

- A. Terapeuta prowadzący proces
- B. Instytucja organizująca usługę
- C. Strony zależnie od źródła błędu
- D. Producent użytej platformy

Jak traktować preferencję klienta dotyczącą modalności?

- A. Jako decydujące kryterium wyboru
- B. Jako kryterium wyłącznie pomocnicze
- C. Jako jedno z kryteriów kwalifikacji
- D. Jako czynnik niezależny od ryzyka

Co najlepiej odróżnia profesjonalną interwencję cyfrową od produktu konsumenckiego?

- A. Personalizacja i nowoczesny interfejs
- B. Popularność i regularne aktualizacje
- C. Dowody skuteczności klinicznej
- D. Automatyzacja i łatwa dostępność

Jak najlepiej oceniać rzeczywistą poprawę kliniczną?

- A. Przez zmianę wyniku skali
- B. Przez wzrost regularności pomiaru
- C. Przez zmianę funkcjonowania i objawów
- D. Przez deklarowaną satysfakcję klienta

Co zrobić, gdy zdalność zwiększa dostępność, ale utrudnia ocenę ryzyka?

- A. Zwiększyć częstotliwość kwestionariuszy.
- B. Kontynuować przy zgodzie klienta
- C. Przejść na model hybrydowy lub stacjonarny
- D. Skrócić odstępy między sesjami

Czy większa ilość danych oznacza lepsze rozumienie klienta?

- A. Tak, jeśli pomiar jest ciągły
- B. Tak, jeśli analiza jest automatyczna
- C. Nie, jeśli dane są pozbawione kontekstu
- D. Nie, jeśli dane mają charakter ilościowy